COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC

N° : 200-17-031362-205

DATE : 5 octobre 2020

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s.

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE, personne morale de droit public légalement constituée en vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* (RLRQ, c. O-7.2), exerçant ses principales activités au 2915, avenue du Bourg-Royal, Québec, province de Québec, G1C 3S2, district de Québec

Demandeur

c.

VINCENT DALLAIRE (9 octobre [redacted] province de Québec [redacted] actuellement hospitalisé à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, 2601, chemin de la Canardière, Québec, province de Québec, G1J 2G3, district de Québec

Défendeur

et

LUC DALLAIRE [redacted]

Mis en cause

JUGEMENT
(portant sur une demande pour autorisation de soins)

---

[1] Le demandeur, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale « (CIUSSS de la Capitale-Nationale) », est une personne morale de droit public et un établissement de santé et de services sociaux au sens de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux*[1] ayant, entre autres, une mission de centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dont de soins psychiatriques.

[2] Le défendeur, M. Vincent Dallaire, est un homme de 22 ans, célibataire et sans enfant. Il habite chez son père, mais il a prévu éventuellement un déménagement afin de pouvoir compléter ses études. Il a présentement une scolarité de niveau universitaire, soit un an en génie mécanique, puis un an en génie informatique.

CONTEXTE

[3] De février à juillet 2020, M. Dallaire reçoit une médication antipsychotique par injection, médication devant lui procurer le soulagement dont il a besoin.

[4] Toutefois, ne s'étant pas présenté à son injection prévue le 8 août 2020, M. Dallaire a été amené à l'urgence de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus dans les jours suivants, soit le 11 août, pour une évaluation en vue d'une garde en établissement. Depuis, il refuse de recevoir toute médication et demeure hospitalisé dans un établissement du demandeur.

[5] Les deux psychiatres qui ont procédé à son évaluation, les 12 et 14 août 2020, ont conclu à la nécessité d'une garde en établissement de trente (30) jours et ont posé un diagnostic de schizophrénie décompensée avec délires de persécution.

[6] Au soutien de sa demande, le demandeur produit un rapport de la D^re^ Sophie L'Heureux, psychiatre attachée à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec « (IUSMQ) », daté du 25 août 2020, de même qu'un rapport du Dr Alain Dion, psychiatre, également attaché à l'IUSMQ. Le Dr Dion signe son rapport le 2 septembre 2020.

[7] Selon les rapports et le témoignage de la D^re^ L'Heureux, le diagnostic principal retenu est la schizophrénie. M. Dallaire présente un prodrome psychotique au cours de l'été et de l'automne 2019 qui nécessite une hospitalisation en novembre 2019. D^re^ L'Heureux confirme alors la présence d'idées délirantes de persécution et d'hallucinations auditives au cours de l'hiver 2020.

LES FAITS

[8] À la suite de l'hospitalisation de novembre 2019, M. Dallaire reçoit une médication antipsychotique, de novembre 2019 à juillet 2020.

---

1 RLRQ, chapitre S-4.2.

[9] Les résultats ont été concluants et M. Dallaire lui-même confirmait alors, en janvier 2020, qu'il y avait une amélioration de sa condition de santé.

[10] Cette condition l'amène alors à faire des projets pour le futur et à s'inscrire à l'Université de Sherbrooke pour septembre 2020.

[11] À la fin mars 2020, alors qu'il se trouve à la fin des effets de sa médication injectable, M. Dallaire soutien qu'il n'a jamais fait de psychose, qu'il n'est pas malade et qu'il a accepté la médication afin de pouvoir mener à bien ses projets d'études.

[12] Le 8 août 2020, lorsqu'il qu'il fait défaut de se présenter afin de recevoir sa médication par injection, il remet en question ses projets d'études. Il devient alors désorganisé, ce qui nécessite, tel que mentionné plus haut, une nouvelle hospitalisation.

[13] Alors qu'il avait jusqu'à ce jour collaboré afin de recevoir le traitement répondant à sa condition mentale, M. Dallaire refuse dorénavant toute médication, maintient que cette médication lui cause des dommages et qu'il n'a jamais fait psychose.

LA PREUVE

[14] Dre L'Heureux à conclut que la rechute actuelle est survenue en fin de dose d'injection :

> **Monsieur Dallaire est à risque de détérioration importante.**
>
> [...] et l'absence de traitement depuis deux semaines ne peut que laisser la place à une rechute plus sévère avec risque de nouveau passage à l'acte. L'extension du délire à l'équipe traitante n'est pas rassurante à ce niveau.
>
> De plus, nous savons que le pronostic de fonctionnement social et occupationnel diminue à mesure de rechutes psychotiques répétées.
>
> [...]
>
> **DÉTAILS CONCRETS DE L'APPLICATION DE L'AUTORISATION DE SOINS :**
>
> [...]
>
> De plus, la prévention des rechutes psychotiques est essentielle, car les données d'études prospectives démontrent que plus longue est la rémission de la psychose, meilleures sont les probabilités d'un rétablissement fonctionnel. Comme les traitements pharmacologiques sont nécessaires, mais insuffisants, un suivi intensif spécialisé et interdisciplinaire est requis, incluant diverses approches dont l'efficacité est maintenue reconnue dans ambiguïté.[2]

---

2 Rapport de la Dre Sophie L'Heureux (pièce P-2020-3), page 6.

[15] Dre L'Heureux précise que les effets bénéfiques des antipsychotiques qu'elle entend administrer à M. Dallaire lui assureront un meilleur contact avec la réalité et lui permettront de retrouver un degré de fonctionnement adéquat et satisfaisant, tant au niveau de ses emplois et de ses études, qu'au niveau de la vie autonome en logement et de la vie en société.

[16] Dre L'Heureux précise qu'il est urgent de s'assurer que M. Dallaire reçoive la médication requise, un suivi externe complémentaire et, au besoin, une hospitalisation.

[17] Dre L'Heureux soumet que le traitement recherché doit se poursuivre sur une période de deux (2) ans, période justifiée par le fait qu'il faille s'assurer que M. Dallaire n'est pas susceptible de rechuter.

[18] M. Vincent Dallaire s'est fait entendre. Ce dernier mentionne qu'il n'a aucunement besoin d'une médication et, qu'à son avis, les dispositions du *Code civil du Québec* qui prescrivent les modalités permettant au demandeur d'agir à la suite d'un jugement pour autorisation de soins sont « *grotesques et ridicules* ».

[19] Il interprète les intentions de la Dre L'Heureux face à lui comme étant malicieuses et qu'elle tend à vouloir lui administrer une forme de poison.

[20] Selon lui, il a fait la preuve qu'il est fonctionnel et qu'il va bien, mais il accepterait tout de même de recevoir une forme de psychothérapie, puisqu'à long terme, la médication que le demandeur cherche à lui administrer aurait des effets négatifs et causerait des dommages à ses organes vitaux.

[21] Tout cela, selon lui, parce que Dre L'Heureux interprète mal ce qu'il lui traduit comme étant sa réalité.

[22] Au soutien de ses prétentions, le défendeur a fait entendre ses parents. Mme Suzie Leblanc et M. Luc Dallaire. Ces derniers soutiennent que, bien que conscients que leur fils doit apprendre à gérer son anxiété et son stress, l'équipe traitante doit mettre à sa disposition des moyens moins invasifs, autres que la médication, et que dans cet objectif, ils sont prêts à le soutenir, tant financièrement que de toute autre manière.

[23] Ils appuient leur fils et sont en accord avec le fait qu'il refuse toute forme de médication. Son état actuel ne justifie pas, selon eux, les traitements suggérés par le demandeur.

ANALYSE ET DÉCISION

[24] Essentiellement, le Tribunal doit déterminer si M. Dallaire est apte ou non à consentir ou à refuser les traitements envisagés par le demandeur.

[25] À plusieurs reprises, tel que le démontre la preuve, M. Dallaire, à la suite d'évènements de perte de contrôle, a dû faire face à la justice et répondre de ses actes.

[26] Dre L'Heureux précise que sans un traitement adéquat, sans une médication comme le suggère la demande introductive d'instance, M. Dallaire est à risque, lorsqu'il est hors de l'hôpital, notamment puisqu'il sera soumis à des éléments stressants extérieurs.

[27] M. Dallaire n'a produit aucune preuve contredisant les conclusions auxquelles en arrivent les Drs L'Heureux et Dion.

[28] À la lumière de la preuve dont il dispose, le Tribunal en vient à la conclusion que le défendeur est présentement inapte

[29] En effet, M. Dallaire ne comprend pas la nature de sa maladie, pour laquelle le demandeur propose un traitement. Il ignore le diagnostic de schizophrénie et émet des propos contradictoires quant au fait qu'il aurait ou non vécu une psychose.

[30] Il est convaincu d'avoir raison dans sa méfiance face à la médication et aux réactions qu'elle pourrait susciter. De plus, chaque fois qu'il a dû répondre aux éléments extérieurs stressants ou anxiogènes, ses réactions étaient justifiées ou attribuables à une « mauvaise gestion du stress ».

[31] M. Dallaire ne comprend pas la nature et le but du traitement proposé. En refusant toute forme de médication, il fait preuve d'une absence d'autocritique face à la maladie. Il ne croit nullement que le traitement suggéré peut changer ses perceptions ou réduire les risques de comportements agressifs et lui éviter des problèmes légaux tels que ceux auxquels il a dû faire face depuis 2018.

[32] En mentionnant que les médicaments pourraient avoir des effets secondaires à long terme, notamment, des dommages à ses organes vitaux, M. Dallaire surévalue les effets secondaires de la médication. Il n'est pas en mesure de considérer que les bénéfices qu'il en retirerait dépasseraient largement les inconvénients liés aux effets secondaires.

[33] Conséquemment, M. Dallaire ne comprend pas les risques encourus à ne pas subir le traitement. Il ne reconnait pas la détérioration actuelle et les risques hétéroagressifs liés à une rechute psychotique.

[34] Enfin, sa capacité à consentir est grandement affectée par la maladie.

[35] Le Tribunal estime que les chances de réussite du traitement sont à considérer, notamment puisque, selon le témoignage de M. Dallaire, il a, pendant un certain temps, repris un fonctionnement organisé au travail et ses projets d'études étaient réalistes, et ce, pendant la période où il a pu tirer des bénéfices du traitement suggéré.

[36] Toutefois, la rechute actuelle est survenue en fin de dose, tel que mentionné par Dre L'Heureux, ce qui laisse croire qu'une rechute plus sévère est à envisager, vu la période trop longue depuis le dernier traitement.

[37] **CONSIDÉRANT** les représentations de la Dre L'Heureux concernant le choix du traitement, la possibilité de contrer les effets indésirables de ce traitement.

[38] **CONSIDÉRANT** le suivi psychiatrique interdisciplinaire suggéré.

[39] **CONSIDÉRANT** les représentations faites concernant la durée nécessaire au traitement.

[40] **CONSIDÉRANT** que sans une application immédiate de l'ordonnance de soins, M. Dallaire pourrait être à risque, s'il retournait à l'extérieur, de rechuter rapidement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[41] **ACCUEILLE** la demande;

[42] **AUTORISE** le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à communiquer au tribunal les documents et renseignements contenus au dossier de M. Vincent Dallaire;

[43] **AUTORISE** les professionnels et les intervenants des établissements qui ont dispensé, dispensent ou dispenseront des soins à M. Vincent Dallaire, à échanger, communiquer et/ou transmettre les documents et/ou les renseignements contenus aux dossiers de M. Vincent Dallaire lorsque cela est nécessaire aux soins à dispenser;

[44] **AUTORISE** le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à Vincent Dallaire, malgré le refus catégorique de celui-ci, à le traiter selon le plan de soins suivant :

a) une médication antipsychotique déterminée en fonction de son évolution clinique incluant notamment, seule ou de façon combinée, Abilify Maintena, Invega Sustenna/Trinza, Risperdal, Fluanxol, Latuda, Seroquel, Zyprexa, Saphris, Rexulti, clozapine;

b) une médication afin de contrer les effets indésirables de la médication psychiatrique déterminée en fonction de son évolution clinique incluant notamment, seule ou de façon combinée, Hypoglycémiant, Hypocholestérolémiant, médication antiparkinsonienne, Dostinex, Colace, Senokot, médicaments diminuant la sécrétion de l'acide gastrique;

c) l'administration de la médication doit pouvoir s'effectuer par quelque mode que ce soit, incluant par injection intramusculaire;

d) en lien avec sa condition physique et psychiatrique ainsi que le plan de soins autorisé, des prélèvements périodiques, des analyses et des examens, comprenant notamment : prélèvements sanguins et d'urine, examens physiques et de laboratoire, électrocardiogrammes, électrœncéphalogrammes et imageries cérébrales;

e) l'hospitalisation, incluant les rencontres avec les membres de l'équipe traitante, jusqu'à ce que son état permette un congé hospitalier et, par la suite, de façon transitoire et temporaire;

f) un suivi externe à la fréquence et selon les modalités déterminées par le médecin traitant ou par l'équipe de suivi externe, incluant notamment un suivi intensif dans la communauté / un suivi par un pharmacien communautaire;

[45] **AUTORISE** le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à M. Vincent Dallaire, à le contraindre à respecter le plan de soins en utilisant tous les moyens appropriés;

[46] **ORDONNE** à M. Vincent Dallaire de fournir au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ou à tout autre établissement qui dispenserait des soins à M. Vincent Dallaire, ses nouvelles coordonnées en cas de changement;

[47] **AUTORISE** les professionnels et les intervenants des établissements qui dispenseraient des soins à M. Vincent Dallaire à communiquer avec les membres de la famille de M. Vincent Dallaire concernant les aspects relatifs à la conduite du traitement;

[48] **ORDONNE** au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ou à tout autre établissement qui exécuterait le présent jugement, de s'assurer qu'un médecin fasse rapport quant à la situation de M. Vincent Dallaire au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l'établissement concerné dans les six (6) mois du présent jugement et, par la suite, à tous les six (6) mois, que, dans un délai raisonnable à la suite de la réception des rapports périodiques, le CMDP étudie, directement ou par l'intermédiaire de l'un de ses comités, lesdits rapports, qu'une copie de ces rapports soit déposée au dossier d'usager de M. Vincent Dallaire et qu'une copie soit déposée au dossier de la Cour;

[49] **AUTORISE** le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, ou tout autre établissement qui dispenserait des soins à M.

Vincent Dallaire, les professionnels et les intervenants des établissements qui dispenseraient des soins à M. Vincent Dallaire, à faire appel, même verbalement, aux policiers ou ambulanciers afin d'être assistés dans l'exercice de ces autorisations et ordonnances, incluant les transferts vers le ou les milieux appropriés, quel que soit le lieu où se trouve Vincent Dallaire;

[50] **ORDONNE** l'exécution du présent jugement pour une période de deux (2) ans à compter de la date du présent jugement;

[51] **AUTORISE** le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale à remettre ou transmettre une copie du présent jugement à Vincent Dallaire et à Luc Dallaire;

[52] **ORDONNE** que le présent jugement soit exécutoire, malgré appel, dès ce jour;

[53] **LE TOUT**, sans frais de justice.

JOHANNE APRIL, j.c.s.

Me Marylie Gosselin
CIUSSS Capitale-Nationale
2915 avenue du Bourg-Royal
Québec (Québec) G1C 3S2
Pour le demandeur

Me Denis Richard
Labrecque Doyon Avocats
400, boul. Jean-Lesage, Tour Est, bur. 115
Québec (Québec) G1K 8W1
Pour le défendeur

Date de l'audience : 1er octobre 2020